

TEMA 1.1 • PEDIATRÍA

Ictericia Neonatal

PERFIL EUNACOM 2.01.1.121

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Ictericia Neonatal

Generalidades y Clasificación

La **ictericia neonatal** es uno de los temas más frecuentes en el EUNACOM. El riesgo principal es la **encefalopatía hiperbilirrubinémica (kernícterus)**, que produce parálisis cerebral por impregnación de los ganglios de la base, con síndrome extrapiramidal y eventual retraso mental. Es una parálisis cerebral **prevenible**.

La ictericia se clasifica según el momento de aparición y su causa:

TABLA 1.1.1: TIPO VS INICIO

TIPO	INICIO	PREDOMINIO	CAUSAS PRINCIPALES
Precoz	< 24 horas de vida	Indirecto	Hemólisis (ABO, Rh), Sepsis, Crigler-Najjar
Fisiológica	Día 2-5	Indirecto	Inmadurez hepática, mala lactancia, cefalohematoma
Tardía	> día 6-7	Variable	Hipotiroidismo, ictericia por leche materna
Prolongada	> 10 días	Variable	Hipotiroidismo, leche materna, atresia biliar

NOTA CLÍNICA

La **bilirubina indirecta = bilirubina no conjugada** es la que cruza la barrera hematoencefálica y produce kernícterus.

Ictericia Fisiológica

Causa: La producción de bilirubina supera la capacidad hepática de conjugación en los primeros días de vida.

Factores agravantes:

- Mala técnica de lactancia / hipoalimentación
- Cefalohematoma (hemólisis extravascular)
- Prematuridad:** ictericia más frecuente, más severa, de inicio más tardío y mayor duración (puede ser fisiológica hasta el día 15 en un RN de 34 semanas)

Perfil temporal:

- Inicio: día 2-5
- Duración: hasta día 7 (máximo día 10)
- Extensión: hasta muslos (no más allá de rodillas)
- Predominio **indirecto**

Diagnóstico: Clínico. Se solicita bilirrubina total si llega bajo las rodillas (evalúa severidad).

Tratamiento:

- Observación + asegurar buena lactancia materna
- Fototerapia** si supera el umbral del normograma
- Exanguinotransfusión** en casos graves

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En el normograma para fototerapia: - A **menor edad** (días de vida) → umbral más bajo para fototerapia - A **menor edad gestacional** → umbral más bajo - **Factores de riesgo** (asfixia, déficit enzimáticos) → bajan el umbral - Cortes aproximados al día 3: RN bajo riesgo ≈ 21 mg/dL | riesgo intermedio ≈ 18 | alto riesgo ≈ 15 mg/dL

Ictericia Precoz (< 24 horas)

- Siempre **patológica**. Estudio inicial:
- Hemograma (buscar anemia: hematocrito < 45% en RN)
- Grupo y Rh del niño

- Coombs directo** (en el RN)
- Hemocultivos (descartar sepsis)
- Si hay fuerte historia familiar → sospechar **Síndrome de Crigler-Najjar**

Tratamiento: Fototerapia (casi siempre) ± exanguinotransfusión.

Ictericia Hemolítica

Incompatibilidad ABO (grupo clásico)

- Madre grupo **O**, RN grupo **A** o **B** - Puede ocurrir desde el **primer embarazo** (no requiere sensibilización previa) - Coombs directo positivo - Hemograma con anemia + esquistocitos (hemólisis intravascular)

Incompatibilidad Rh

- Madre **Rh negativa**, RN **Rh positivo** (padre Rh positivo) - Ocurre desde el **segundo embarazo** en adelante (requiere sensibilización previa) - Coombs directo positivo

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

El Coombs **directo** se hace en el **RN** (busca anticuerpos sobre sus glóbulos rojos). El Coombs **indirecto** se hace en la **madre** (busca anticuerpos libres en su sangre).

Profilaxis de Isoinmunización Rh

Solo aplica a mujeres **Rh negativas no sensibilizadas** (Coombs indirecto **negativo**).

- Indicaciones del Rogam (inmunoglobulina anti-D):**
- Posparto** (dentro de 72 horas) → evita el 90% de la sensibilización
- Semana 28** de gestación → evita el 9% adicional
- Cualquier evento con intercambio sanguíneo materno-fetal: aborto, embarazo ectópico, mola, amniocentesis, biopsia de vellosidades coriales, metrorragia

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Con **posparto + semana 28** se previene el **99%** de la sensibilización Rh.

Si el Coombs indirecto es **positivo** (ya sensibilizada): seguimiento con Doppler de arteria cerebral media fetal. Si anemia fetal severa y muy prematura → **transfusión intrauterina** con sangre O Rh negativa.

Ictericia Tardía y Prolongada

Manejo: Solicitar bilirrubina total + directa (diferenciada).

TABLA 1.1.2: PREDOMINIO VS SOSPECHA

PREDOMINIO	SOSPECHA	EXAMEN
Indirecto	Hipotiroidismo	TSH
Indirecto + TSH normal	Ictericia por leche materna	Diagnóstico de descarte
Directo	Atresia biliar primaria	Ecografía abdominal

Ictericia por Leche Materna

- Inicio: día 4-7, máximo entre día 14-20 - Puede durar 1-3 meses - Predominio **indirecto**, habitualmente < 20 mg/dL - Diagnóstico de **descarte** (descartar hipotiroidismo) - **Tratamiento:** Mantener lactancia materna, aumentar número de tomas. No suspender.

Atresia Biliar Primaria

- Inicio: día 14-21 - Predominio **directo** → coluria (orina color Coca-Cola) + **acolia** (deposiciones blancas) - Diagnóstico: ecografía

abdominal - **Tratamiento quirúrgico:** Cirugía de Kasai (anastomosis hepatoyeyunal) - Debe realizarse **antes de las 8 semanas** (después → cirrosis biliar) - Si falla → **trasplante hepático** (es la causa más frecuente de trasplante hepático en pediatría)

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Si hay **coluria + ictericia tardía** → atresia biliar primaria hasta demostrar lo contrario. Diagnóstico y cirugía deben ser precoces.

Casos Clínicos

Caso 1: RN 20 días, ictericia + coluria → Predominio directo + tardía → **Atresia biliar primaria** → Ecografía abdominal → Cirugía de Kasai.

Caso 2: RN 5 días, ictericia hasta muslos iniciada al día 3. Madre O Rh+, RN A Rh-. → Perfil temporal y extensión fisiológica → **Ictericia fisiológica** (incompatibilidad ABO no es suficiente para diagnosticar hemolítica sin clínica patológica).

Caso 3: RN 18 días, ictericia hasta muslos, bilirrubina 15 mg/dL, directa 2, TSH normal, lactando → **Ictericia por leche materna** → Educar, mantener lactancia.

Caso 4: RN 2 días, ictericia marcada a las 12 horas. Madre O Rh-, primípara, RN A Rh+ → Ictericia precoz + incompatibilidad ABO y Rh. Como es primípara (no sensibilizada aún a Rh), lo más probable es **hemólisis por incompatibilidad ABO**.

- **Caso 5:** RN 10 horas, ictericia. Madre Rh-, múltipara, RN B Rh+ → Ictericia precoz + madre Rh- múltipara (ya sensibilizada) → **Hemólisis por incompatibilidad Rh**.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"RN de 38 semanas, 36 horas de vida, con bilirrubina total de 14 mg/dL. Madre O+, RN A+. Coombs directo negativo. ¿Cuál es la conducta correcta según las curvas de Bhutani?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Ictericia Neonatal. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Generalidades y Clasificación
- Ictericia Fisiológica
- Ictericia Precoz (< 24 horas)
- Ictericia Hemolítica
- Incompatibilidad ABO (grupo clásico)
- Incompatibilidad Rh
- Profilaxis de Isoinmunización Rh

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ICTERICIA NEONATAL)

PREGUNTA 1

RN de 38 semanas, 36 horas de vida, con bilirrubina total de 14 mg/dL. Madre O+, RN A+. Coombs directo negativo. ¿Cuál es la conducta correcta según las curvas de Bhutani?

- A) Fototerapia inmediata
- B) Observación y control a las 24h con nueva bilirrubina
- C) Exsanguinotransfusión de urgencia
- D) Alta hospitalaria con control ambulatorio en 72h
- E) Suspender lactancia materna 48h

PREGUNTA 2

¿Cuál de los siguientes hallazgos indica ictericia PATOLÓGICA en un RN?

- A) Ictericia que aparece al 3er día de vida
- B) Bilirrubina directa de 0.5 mg/dL
- C) Ictericia que aparece en las primeras 24 horas de vida
- D) Bilirrubina total de 12 mg/dL al 4to día en RN de término
- E) Ictericia que se resuelve a los 10 días en RN de término

PREGUNTA 3

RN de 35 semanas con bilirrubina de 18 mg/dL a las 48h. Se inicia fototerapia. ¿Qué complicación grave justifica la exsanguinotransfusión si no hay respuesta?

- A) Anemia hemolítica leve
- B) Kernicterus (encefalopatía bilirrubínica)
- C) Hipoglicemia neonatal
- D) Sepsis neonatal tardía
- E) Retinopatía del prematuro

RESUMEN: ICTERICIA NEONATAL

La ictericia neonatal es uno de los temas más frecuentes en el EUNACOM. El riesgo principal es la encefalopatía hiperbilirrubinémica (kernícterus), que produce parálisis cerebral por impregnación de los ganglios de la base, con síndrome extrapiramidal y eventual retraso mental. Es una parálisis cerebral prevenible. ::note La bilirubina indirecta = bilirubina no conjugada es la que cruza la barrera hematoencefálica y produce kernícterus. ::: Causa: La producción de bilirrubina supera la capacidad hepática de conjugación en los primeros días de vida.